Sacar copia
p' Dra.

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA
SERVICIO DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA
PACIENTE: LUIS ANTONIO CANALES GUERRERO
NSS: 2090 73 1985-7 3M2005 OR
PESO: 17 KG
TALLA: 1.20 MTS
17 DE DICIEMBRE DEL 2012

ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA

Se trata de paciente masculino de 7 años de edad, quién es enviado vía interconsulta del servicio de Infectología Pediátrica, con diagnóstico de probable inmunodeficiencia. Ha estado en protocolo de estudio por Neumología, por tos persistente, aún sin concluir diagnóstico. Está en tratamiento con Fluticasona, y con Carbamacepina (durante 6 meses) por resultado de Electroencefalograma (niega haber presentando crisis convulsivas), tiene trastorno de la atención. Niega antecedente de Neumonía, niega antecedentes de infecciones a nivel digestivo, niega otitis, sinusitis. Cursa con faringitis aproximadamente 10 eventos al año, tiene síntomas nasales rinorrea hialina, estornudos en salva, prurito, con afección en el sueño, respiración oral, ronquidos, sin afección ocular, ha tenido síntomas bronquiales que han ameritado tratamiento con nebulizaciones 2 veces en el año. Tiene tos diariamente, tos cuando corre.

Espirometría: 3 de Julio 2012, Obstrucción general de grado severo, con paupérrima respuesta al broncodilatador.
Lab. 15 de Octubre 2012 IgA 45 mg/dl, IgG 584 mg/dl, IgM 51.4 mg/dl, IgE 69.43 UI/ml, HIV Negativo, Hepatitis B, C, CMV IgG e IgM Negativo.
29 de Noviembre 2012: BH Leucocitos 7040, Neutrófilos 3820, Linfocitos 2570, Eosinófilos 120, Hb 14.6, Hto 42.3, Plaquetas 362000. IgA 77 mg/dl, IgG 700 mg/dl, IgM 91 mg/dl. Rangos normales para su edad: IgA 33-202mg/dl, IgM 48-207 mg/dl, IgG 633-1280 mg/dl.
Subpoblaciones de linfocitos: LTCD3+ 68.14% (1823.94) rango normal 700-1200, LTCD8+ 22.41% (599.85) rango normal de 300 a 1800, LTCD4+ 39.81% (1065.59) rango normal de 300 a 2000.

AYP: Rinitis moderada persistente, Asma moderada persistente.
Se realizan pruebas cutáneas a Aeroalergenos: NEGATIVAS.
No amerita inmunoterapia, no amerita ingreso al servicio, sin datos clínicos ni de laboratorio que integren diagnóstico de Inmunodeficiencia primaria, si puede afectarse su sistema inmunológico pero de forma secundaria a la desnutrición, control y seguimiento en su HGZ por Pediatría, ORL y en su UMF. Alta de Inmunología Clínica y Alergia tercer nivel.

DR. MARCO ANTONIO VENANCIO HERNÁNDEZ. MAT. 10880844
ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA. MEDICINA INTERNA.

UNIDAD MEDICA DE ALTAESPECIALIDAD
CENTRO MEDICO NACIONAL
"LA RAZA"
Servicio de Otorrinolaringologìa
Departamentos de FONIATRIA
LUIS ANTONIO CANALES GUERRERO
2090 73 1985 3m 05ord

NOTA DE EVOLUCION DE FONIATRIA

01/04/14 12:00 AM

Se trata de paciente masculino de 8 año 9 meses de edad enviado de Neumo- pediatría con los DX: Disfagia en estudio el paciente refiere mejoría,

EF: tranquilo, consciente, con actitud de normoyente, sin alteraciones, cráneo sin endo ni exositosis, otosocopia, dentro de límites normales, cavidad oral en buenas condiciones. Con tono y fuerza disminuidos en mejillas, lengua y orbicular de los labios nariz con puente nasal ancho, cornetes en ciclo, faringe hiperemica. Cuello, con adecuado tono para un sostén cefálico.

FEES: Se realiza bajo técnica habitual, en la 4 consistencias encontrando alteraciones en los liquidos , a partir de 10 ml, y con residuo en solidos a partir de 1/2 galleta.

IDX: **DISFAGIA OROFARINGEA, síndrome de silver y russell**

PLAN

1. *CUIDADOS* DE VOZ (No gritar, reposos vocal)
2. EJERCICIOS LINGULAES, LABIALES, se inicia sensibilidad y tono de musculatura facial, y cavidad oral.
3. Se sugiere uso de cepillos dentales
4. Agua tibia y a temperatura ambiente con una gasita
5. Digito presión, en sonrisa zigzag, tristeza,
6. Masaje en cavidad oral en círculos en cavidad oral y base de lengua
7. CITA ordinaria

DRA CUAUHTECA MB

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CONTRARREFERENCIA

NSS : 2090-73-1985 **A. MED.: 3M2005OR**

NOMBRE DEL PACIENTE

LUIS ANTONIO CANALES GUERRERO

DELEGACIÓN: 2 NORESTE D.F.

UNIDAD: HOSPITAL GENERAL C.M.R. **CVE PTAL. 36A101112153**

CONSULTORIO: GST1 **TURNO: VESPERTINO**

UNIDAD A LA QUE SE ENVIA: **Hospital de Gineco Pediatría No. 3A** DELEGACIÓN: **1 Noroeste D.F.** CONSULTORIO: _

Fecha y hora de la cita en 1er o 2o nivel: _

FECHA DE PRIMERA CONSULTA: |2|8|0|7|2|0|1|4|

FECHA DE ALTA DEL SERVICIO: |2|9|0|9|2|0|1|4|

DIAGNÓSTICO(S) INICIAL(ES): Asma infantil,

DIAGNÓSTICO(S) FINAL(ES):

Asma infantil,

TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS: 2

RESUMEN CLÍNICO

MASCULINO DE 8 AÑOS 10 MESES DE EDAD, DX DE SX SILVER RUSELL, TRASTORNO DEFICIT DE ATENCION, ASMA EN TRATAMIENTO, ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA, DESNUTRUCION. EN ULTIMA CITA SE INICIA TRATAMIENTO CON IBP Y DIETA POLIMERICA, HA INCREMENTADO DE PESO Y MANTIENE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO ADECUADA PARA SU EDAD DE 0.57 CM/MES.PRESENTA EVACUACIONES DIARIAS BRISTOL TIPO 1 CON ESFUERZO CON DOLOR AL DEFECAR, NO SANGRADO, NO TAPA RETRETE. CUENTA CON PC N O REACTIVAS A ALIMENTOSSEGD CON ENGROSAMIENTO DE PLIEGUES GASTRICOS. MECANICA DE DEGLUCION SIN ALTERACIONES. GAMMAGRAMA POSITIVO PARA RGE A TERCIO SUPERIOR DE ESOFAGO. NO REPOTAN INDICE, TIEMPO DE VACIAMIENTO GASTRICO PROLONGADO PARA TIPO DE DIETA. RASTREO PULMONAR NEGATIVO PARA ASPIRACION. REFIERE DOLOR EN HIPOCONDRIO IZQUIERDO Y LUMBAR EN CITA REGISTRADA EL 14-04-14. SE PRESENTA EL DIA DE HOY CON PARACLINICOS CON BH, QS,ES, PFH, NORMALES CON UROCULTIVO SIN DESARROLLO., USG ABDOMINAL CON APARENTE ESPLENOMEGALIA, RESTOS IN ALTERACIONES. COMENTA LA MADRE QUE YA SUSPENDIO OMEPRAZOL TRAS 3 MESES, CONTINUA POLIETILENGLICOL 20G/DIA CON PATRON EVACUACION DIARIO NORMAL. MENCIONA EN CITA POR NEUMOLOGIA DIERON METOCLOPRAMIDA, YA QUE CURSADA CON REGURGITACIONES SIN VOMITOS QUE CONTINUAN HASTA FECHA ACTUAL, POR NUESTRA PARTE DAMOS METOCLOPRAMIDA CONTRARREFERENCIA A SU HGZ ASI COMO POLIETILENGLICOL. CITA EN EL AÑO 2015.. PP-3 PT3 CONCIENTE, REACTIVO, HIDRATADO., TORAX CON CARDIOPULMONAR SIN COMPROMISO., ABDOMEN BLANDO, DEPRESIBLE CON PERISTALSIS AUDIBLE, RESTO SIN RELEVANTES.

PRONÓSTICO: SE ESPERA BUENO CON TRATAMIENTO

LA INFORMACIÓN SIGUIENTE ES FUNDAMENTAL PARA EL SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS AL PACIENTE EN LA UNIDAD MÉDICA DE ORIGEN

INDICACIONES DE USO DE MEDICAMENTO

MEDICAMENTOS

NOMBRE GENÉRICO	DOSIS	TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN	REQUERIMIENTO MENSUAL
Metoclopramida solucion cada ml contiene: clorhidrato de metoclopramida 4 mg envase frasco gotero con 20 ml. SOLUCION ORAL 4 MG / ML	14 GOTA (S) c/ 8 HORA(S)	30 DÍA(S)	4 ENV
Polietilenglicol polvo cada sobre contiene: polietilenglicol 3350 105 g envase con 4 sobres. POLVO 105 g	1 CUCHARADA (S) c/ 12 HORA (S)	30 DÍA(S)	12 ENV

OTRAS MEDIDAS TERAPEUTICAS O DE CONTROL:

Requiere Transcripción de Medicamentos en su unidad de origen durante 12 meses.

MÉDICO RESPONSABLE
(NOMBRE,MATRICULA Y FIRMA)

SENEN MARINO TELLEZ SALMERON
99363854

MÉDICO DIRECTIVO QUE AUTORIZA
(NOMBRE,MATRICULA Y FIRMA)

Dra cuauhtea

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

Hospital General
Imagenologia

Folio HG-373424

DATOS DEL PACIENTE				
CANALES GUERRERO LUIS ANTONIO	03140502261 M2005SF	1M2005SF	Masculino	10 Años

DATOS DEL ESTUDIO		
SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL (PEDIATRICO)	FLUROSCOPIA	jueves, 17 de diciembre de 2015

SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL
REPORTE:

Se realiza estudio contrastado previo consentimiento informado del familiar y bajo control fluoroscópico, administración de medio de contraste baritado vía oral observando:

Mecánica de la deglución sin alteraciones.

Esófago de forma, situación y distensibilidad normales; se observa opacificación en forma adecuada en todos sus segmentos. Unión esofagogástrica por debajo del hemidiafragma izquierdo.

Estómago con morfología, distensibilidad y pliegues normales, adecuado paso de contraste hacia duodeno. No se identifica reflujo duodeno gástrico. No se evidencia reflujo gastroesofágico.

Control a los 20 minutos muestra vaciamiento gástrico del 40%. Asas de intestino delgado de morfología y distensibilidad normal. Sin datos de reflujo gastroesofágico.

CONCLUSIÓN:

-ESTUDIO SIN DATOS ACTUALES DE ALTERACION ESTRUCTURAL POR ESTE METODO.

Dr. Alfonso Trejo Hernández Ced. Prof.1270384 Ced. Especialista 3180779
Dr. Herrera R1RX

ALFONSO TREJO HERNANDEZ
Médico Cédula : N/A

jueves, 17 de diciembre de 2015 10:16

INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Campus UNAM Juriquilla, Querétaro
REPORTE DE ELECTROENCEFALOGRAMA

LUIS ANTONIO CANALES GUERRERO
Fecha de nacimiento: 30 de mayo del 2005
Fecha del estudio: 27 de mayo del 2013
Edad en el estudio: 8 años

SEXO: M CÓDIGO: C20696M
EDAD GESTACIONAL: 42 semanas

TECNICA:
Se efectuó estudio de EEG, con los electrodos colocados según el Sistema Internacional 10-20, en montajes bipolares y monopolares, durante el estado de vigilia.

RESULTADOS:
Trazado que se intentó registrar despierto y alerta pero con las características del estado de somnolencia. No se observaron actividad lenta anormal ni actividad paroxística epileptiforme en reposo ni durante las maniobras de activación (hiperventilación y fotoestimulación).

INTERPRETACIÓN:
El electroencefalograma convencional se considera **dentro de límites normales** para la edad del niño y el estado en que se llevó a cabo el registro.

COMENTARIO:
Con relación al estudio realizado el 12 de septiembre del 2012, cuando tenía 7 años de edad, se puede señalar que en el actual no se registró actividad paroxística anormal ni grafoelementos de connotación epileptiforme por lo que se sugiere repetir el estudio con privación de sueño y durante el sueño fisiológico. El niño está bajo tratamiento antiepilético.

ATENTAMENTE

Dra. Josefina Ricardo Garcell
Neurofisióloga Clínica
Cédula Profesional No. 3412402

CONSTANCIA MÉDICA

CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN ESTADO DE MÉXICO
DIRECCION MÉDICA

Tlalnepantla, Estado de México, a 19 de julio del 2012

LICENCIADA NORA ARIAS
JEFA DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO.

P R E S E N T E.

Por medio de la presente se hace constar que la menor de nombre: **LUIS ANTONIO CANALES GUERRERO** es paciente y recibe atención médica y de rehabilitación desde el 24 de Octubre del 2008, en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Estado de México, Turno Vespertino, ubicado en la Avenida Gustavo Baz No. 219, Col. San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla, Estado de México, con número de **carnet: 21153** cuyo diagnóstico del paciente es:

IDX. SINDROME DE SILVER RUSELL, RETRASO PSICOMOTOR GLOBAL SECUNDARIO MODERADO, CON MAYOR AFECTACIÓN EN ÁREAS DE LENGUAJE, PROBLEMAS DEL LENGUAJE, PIE PLANO VALGO GRADO II, TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD, PO DE CIRCUNCISIÓN 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, ASMA BRONQUIAL

Se expide la presente a solicitud de la madre del menor, para los fines que al interesado convengan, para realizar trámites para beca.

ATENTAMENTE.

Dra. Blanca Gabriela Lizeth Legorreta Ramírez
Médico Especialista en Medicina de Rehabilitación
Cédula Profesional 4371428

FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO
EDO. DE MÉX.
R.F.C. FTM981104540

Dra. Virginia Maldonado Villalobos
Director Médico del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón
Estado de México
Fundación Teletón México, A.C